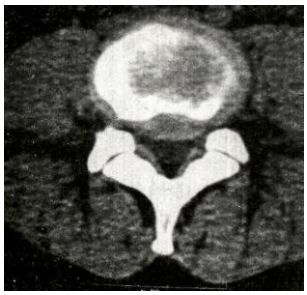
正常生理曲度：颈、胸、腰、骶

④影像　年龄增大→退化　硬碰硬　左右、前后不等宽

| | |
|---|---|
| X 线 | 生理曲度异常、骨质增生、钙化、椎间隙狭窄、椎间盘突出间隙不等宽等。**X 线不能观察椎间盘** |
| CT | 上述 X 线内容+观察椎间盘，但不能清楚观察神经和脊髓等受压情况 |
| **MRI** | 上述 CT 内容，清楚观察**神经和脊髓**等受压情况 |



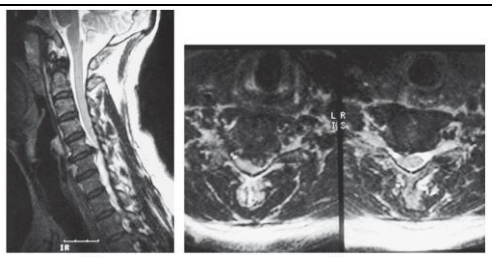


图 69-4　颈 5～颈 6 椎间盘突出
从矢状位（1）及横轴位（2）MRI 上可以看到椎间盘突出压迫硬膜囊及脊髓。

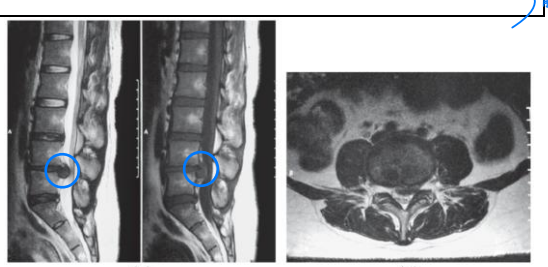


图 69-10　腰 4～腰 5 椎间盘突出的 MRI
矢状位（1）及横轴位（2）MRI 示腰 4～腰 5 较大的椎间盘突出，压迫硬膜囊。

## 二、颈椎病

1.$C_{5\text{-}6}$好发，女性多见（脖子女性多见如甲状腺疾病、我的脖子好 6）
腰的问题一般男的多见，如肾小球肾炎

2.类型

| | 臂丛神经的问题 表现 | 治疗 |
|---|---|---|
| **神经根型**（最常见） | 颈肩痛+上肢放射痛，上肢感觉障碍（麻木）、运动障碍（无力）<br>**Eaton 征、Spurling 征**（eason） | 首选保守<br>（按摩、颌枕带牵引等） |
| **脊髓型**（最严重） | **持物不稳、踩棉花感**，四肢感觉、运动障碍，二便障碍 受累平面以下全出问题<br>上肢 **Hoffmann 征**、下肢 **Babinski 征**（飘、可硬瘫、范围广、哈巴儿） 病理征 | **急诊手术** 只能用颅骨牵引(更加牢固)<br>**禁止按摩、颌枕带牵引** |
| 交感神经型 症征不符 | 交感神经兴奋（心悸、出汗）或抑制的表现（心动过缓、血压↓）<br>症状多、体征少 交感N兴奋:大失血(如宫外孕)、低血糖(皮肤潮湿)、倾倒综合征、甲亢、嗜铬细胞瘤(乱七八糟的血压) | 首选保守 |
| 椎动脉型 | **猝倒**、眩晕、视物模糊 倒地后自己又醒了(体位改变解除压迫使供血恢复) | 首选保守 |
| 食管型 | 吞咽困难 | 首选保守 |

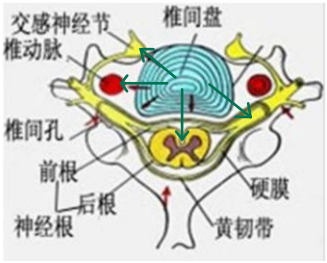





图 69-1　臂丛神经牵拉试验（Eaton 试验）

颌枕带牵引→椎间隙拉宽→减少对神经根的压迫

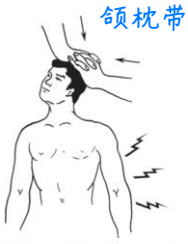


图 69-2　压头试验（Spurling 征）

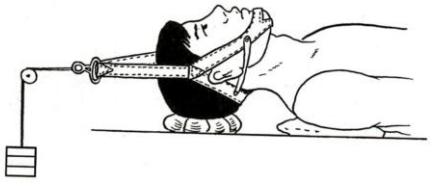


图 58-26　枕颌带牵引

3.**损伤平面判断**

